今日論文 • 第 05 篇 需訂閱／付費

艾灸治療糖尿病周圍神經病變的療效與安全性：32 項隨機對照試驗系統回顧

Efficacy and safety of moxibustion in the treatment of diabetic peripheral neuropathy: A systematic review of 32 randomized controlled trials

作者	Liang J, Yuan L, Li W, Wang H, Yan D, Yu J
期刊	Complementary Therapies in Clinical Practice（2026年11月3日線上發表；65卷，文章 102094）
識別碼	PMID 42987539 • DOI 10.1016/j.ctcp.2026.102094
取用	需訂閱／付費

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42987539/
- DOI（出版社全文，可能需訂閱） https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2026.102094

研究是什麼

系統回顧與 Meta 分析，評估艾灸相對於非艾灸療法，治療糖尿病周圍神經病變（DPN）的療效與安全性。

方法要點

- 檢索七個資料庫，納入比較艾灸與非艾灸療法的隨機對照試驗，並以 Cochrane RoB 2 評估偏倚風險。
- 進行隨機效應 Meta 分析、試驗序貫分析（TSA）、敏感性分析、剪補法及亞組分析。
- 共納入 32 項 RCT，合計 2,545 名受試者。

主要結果

- 相對對照，艾灸顯著提高治療反應（比例比值比 3.74，95% CI 3.00 至 4.65）。
- 並改善正中神經及腓總神經的感覺與運動神經傳導速度，減輕 DPN 症狀嚴重程度，降低丙二醛（MDA）、升高超氧化物歧化酶（SOD）活性。
- 血液流變方面，艾灸降低血漿黏度以及低切變與高切變全血黏度，但對纖維蛋白原無顯著影響。公開摘要未列出各項神經傳導速度的具體差值。
- 試驗序貫分析、剪補法及敏感性分析支持部分發現，惟若干結局在排除高偏倚風險研究或考慮不精確性後較為敏感。
- 亞組分析提示，使用足三里或三陰交，以及療程達 4 周或以上的研究，在部分神經傳導結局上改善較明顯。
- 安全性資料有限：僅 4 項試驗提供安全性信息，該 4 項均未報告不良事件。

中醫診所臨床啟示

- 消渴病痹證或糖尿病周圍神經症狀患者，可將艾灸作為血糖控制及常規西藥的輔助討論，並與內分泌科或家庭醫生協調。
- 不能取代降糖治療、足部護理或血管評估；出現潰瘍、感染、急性缺血或迅速加重的感覺／運動缺損，須及時轉介。
- 向患者說明：有效率優勢來自綜合分析，神經傳導的具體差值未在摘要列出，且安全性報告不完整。

限制與解讀注意

- 公開摘要未提供各神經傳導結局的具體均差，本稿不臆測數值。
- 僅少數試驗報告不良事件，不能據此斷言艾灸在此適應症中必然安全。
- 期刊需訂閱，本摘要只根據已核實的 PubMed 摘要撰寫，完整數據請以出版社全文為準。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。